

CAPÍTULO 13.50

Hipertrofia de Adenoides

PERFIL EUNACOM 5.01.1.002
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **hipertrofia de adenoides** es una patología muy prevalente en la edad pediátrica y una de las consultas más frecuentes en otorrinolaringología. Consiste en el crecimiento excesivo del tejido linfoide ubicado en la rinofaringe (adenoides), lo que puede provocar obstrucción del flujo de aire nasal y compromiso del drenaje del oído medio.

Clasificación de la Hipertrofia Adenoidea

La magnitud de la hipertrofia se clasifica según el porcentaje de oclusión de la vía aérea nasofaríngea, objetivado generalmente a través de imágenes:

TABLA 13.50.1: GRADO VS PORCENTAJE DE OBSTRUCCIÓN		
GRADO	PORCENTAJE DE OBSTRUCCIÓN	HALLAZGO RADIOLÓGICO
Grado 1	Hasta un 33%	Obstrucción leve; la vía aérea se mantiene permeable.
Grado 2	Entre 33% y 66%	Obstrucción moderada de la columna de aire.
Grado 3	Más del 66%	Obstrucción severa; el tejido ocupa casi toda la nasofaringe.

Manifestaciones Clínicas y Complicaciones

Es fundamental destacar que la mayoría de los niños con adenoides grandes son **asintomáticos**. En estos casos, no existe indicación de estudio radiológico ni tratamiento. La relevancia clínica aparece cuando surgen complicaciones, que se dividen en dos grandes grupos:

1. Complicaciones Obstructivas

El crecimiento del tejido impide el paso normal del aire por la nariz, obligando al paciente a buscar vías alternativas. - **Respirador Bucal:** El niño mantiene la boca abierta para respirar, lo que a largo plazo puede alterar el desarrollo maxilofacial (facies adenoidea). - **Trastornos del sueño:** Ronquidos y, en casos severos, apnea obstructiva del sueño.

2. Complicaciones Infecciosas y del Oído

Las adenoides se encuentran en estrecha relación anatómica con la **trompa de Eustaquio** (tuba auditiva). - **Disfunción de la Trompa de Eustaquio:** La obstrucción mecánica o la inflamación impiden el drenaje adecuado del oído medio. - **Patología Ótica:** Esto predispone a **Otitis Media con Efusión, Otitis Media Aguda** recurrente e incluso otitis media crónica. - **Infecciones Respiratorias:** La retención de secreciones por la obstrucción facilita la sobreinfección bacteriana, derivando en **adenoiditis a repetición** o **Sinusitis** recurrente.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La hipertrofia no solo actúa como un "tapón" mecánico; las adenoides también pueden funcionar como un reservorio de bacterias (biofilms) que contribuyen a las infecciones crónicas del tracto respiratorio superior y del oído medio.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero requiere confirmación mediante imágenes para objetivar el tamaño del tejido.

- **Clínica:** Historia de respiración bucal, ronquidos nocturnos e infecciones frecuentes.
- **Radiografía de Cavum Rhinopharyngeum (Radiografía de Cavum):** Es el examen de elección inicial. Permite ver la columna de aire (color

negro) y el tejido adenoideo (color blanco), determinando el grado de obstrucción (1, 2 o 3).

Criterios de Tratamiento y Cirugía

El tratamiento definitivo es la **adenoidectomía** (extirpación quirúrgica de las adenoides). Sin embargo, no todo niño con adenoides grandes debe operarse.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Criterio Quirúrgico EUNACOM: Para indicar una adenoidectomía se deben cumplir simultáneamente dos condiciones: 1. **Evidencia Radiológica:** Hipertrofia Grado 2 o Grado 3. 2. **Clínica de Complicaciones:** Presencia de respirador bucal persistente, apneas, otitis recurrentes o sinusitis crónica/recurrente.

Diagnóstico Diferencial: La Rinitis Alérgica

Es muy común que la hipertrofia de adenoides coexista con la **Rinitis Alérgica**. De hecho, la rinitis es una causa mucho más frecuente de obstrucción nasal y complicaciones infecciosas que la sola hipertrofia adenoidea.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta clínica de rinitis alérgica (estornudos, prurito nasal, rinorrea acuosa) e hipertrofia de adenoides, **el primer paso siempre es tratar la rinitis alérgica**. La cirugía solo se plantea si los síntomas obstructivos persisten tras un tratamiento médico óptimo de la alergia.

- Si hay clínica de rinitis: **Tratamiento médico primero**.
- Si no hay respuesta al tratamiento médico y se cumplen los criterios de grado + complicación: **Adenoidectomía**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 5 años es traído por su madre porque ronca mucho, respira por la boca y ha tenido 3 episodios de otitis media en el último año. La radiografía de cavum muestra adenoides grado 3 con oclusión de más del 80% de la vía aérea nasal. Además refiere estornudos frecuentes, rinorrea acuosa y prurito nasal. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hipertrofia de Adenoides. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Clasificación de adenoides: grado 1 ($\leq 33\%$ oclusión), grado 2 (33-66%), grado 3 ($>66\%$). Se mide con radiografía de cavum.
- La mayoría de los niños con adenoides hipertróficos son asintomáticos y no requieren estudio ni tratamiento.
- Complicaciones obstructivas: respirador bucal, otitis media con efusión, otitis media aguda, otitis media crónica.
- Complicaciones infecciosas: sinusitis recurrente, adenoiditis a repetición (por retención de secreciones).
- Diagnóstico: clínica + radiografía de cavum para objetivar el tamaño.
- Indicación de adenoidectomía: hipertrofia grado 2-3 objetivada + presencia de complicaciones. Sin complicaciones NO se operan.
- La rinitis alérgica es MUCHO más frecuente como causa de respiración bucal, otitis y sinusitis que la hipertrofia de adenoides.
- Si hay clínica de rinitis alérgica concomitante → tratar PRIMERO la rinitis. Solo si no responde → adenoidectomía.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPERTROFIA DE ADENOIDES)**PREGUNTA 1**

Niño de 5 años es traído por su madre porque ronca mucho, respira por la boca y ha tenido 3 episodios de otitis media en el último año. La radiografía de cavum muestra adenoides grado 3 con oclusión de más del 80% de la vía aérea nasal. Además refiere estornudos frecuentes, rinorrea acuosa y prurito nasal. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A)** Adenoidectomía inmediata dado el grado 3 con complicaciones
- B)** Tratar la rinitis alérgica con corticoides nasales y reevaluar
- C)** Solicitar nasofibroscopia para confirmar el diagnóstico
- D)** Iniciar antibióticos profilácticos para las otitis recurrentes
- E)** Observación sin tratamiento hasta los 7 años cuando los adenoides involucionen

PREGUNTA 2

Se solicita radiografía de cavum a un niño de 4 años con obstrucción nasal persistente. El informe describe adenoides que ocluyen aproximadamente el 50% de la vía aérea nasal. ¿A qué grado corresponde esta hipertrofia?

- A)** Grado 1
- B)** Grado 2
- C)** Grado 3
- D)** Grado 4
- E)** No se puede determinar con radiografía de cavum

PREGUNTA 3

Niño de 6 años con radiografía de cavum que muestra adenoides grado 3. La madre refiere que el niño no tiene ningún síntoma: no ronca, respira bien, no ha tenido otitis ni sinusitis. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Adenoidectomía dado que tiene grado 3
- B)** Repetir la radiografía en 6 meses
- C)** No operar; observación clínica
- D)** Iniciar corticoides nasales profilácticos
- E)** Solicitar polisomnografía para descartar apnea subclínica

RESUMEN: HIPERTROFIA DE ADENOIDES

La hipertrofia de adenoides es un tema relevante tanto en pediatría como en otorrinolaringología. Los adenoides se clasifican según el grado de obstrucción de la vía aérea nasal: grado 1 (hasta 33% de oclusión), grado 2 (33-66%) y grado 3 (más de 66%). Esta clasificación se realiza de forma aproximada mediante radiografía de cavum (lateral de cráneo). La gran mayoría de los niños con adenoides hipertróficos son asintomáticos y no requieren evaluación. Cuando producen síntomas, estos pueden ser obstructivos o infecciosos. Las complicaciones obstructivas incluyen la respiración bucal (respirador bucal), la obstrucción de la trompa de Eustaquio con otitis media con efusión, otitis media aguda u otitis media crónica. Las complicaciones infecciosas se producen por retención de secreciones: sinusitis recurrente y adenoiditis a repetición. El diagnóstico se establece con la clínica más la radiografía de cavum para objetivar el tamaño de los adenoides. El tratamiento es la adenoidectomía, pero solo cuando hay hipertrofia real (grado 2-3) objetivada en la radiografía MAS alguna complicación. Sin complicaciones, no se operan. Un punto clave para el EUNACOM: si el paciente tiene además clínica de rinitis alérgica (causa mucho más frecuente de todas estas complicaciones), se debe tratar primero la rinitis alérgica y solo si no responde se procede a la adenoidectomía.